Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es einen Auslöser für die Schmerzen? z. B. Bewegung oder Belastung
Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie früher schon ähnliche Symptome?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen klopfend oder stechend?
Wie stark?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen oder gemacht?
Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Wie oft müssen Sie zum Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin? Gibt es Blut im Urin?
Riecht der Urin stark oder ungewöhnlich?
Müssen Sie auch in der Nacht zum Wasserlassen?
Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Wie viel Urin haben Sie?
Wie viel Wasser trinken Sie täglich?
Ist der Harnstrahl unterbrochen oder dauerhaft?
Ist der Harnstrahl schwach oder stark?
Fühlen Sie Harnreste in der Blase?
Haben Sie Fieber?
Hatten Sie Schüttelfrost?
Haben Sie starkes Schwitzen in der Nacht?
Wie ist Ihr Appetit?
Haben Sie in letzter Zeit stark an Gewicht abgenommen??
Hatten Sie in der Vergangenheit schon Harnwegsinfekte?
Wie oft? (Rekurrenz)
Wurden diese mit Antibiotika behandelt? Wenn ja, welche?
Haben Sie die Antibiotika vollständig eingenommen?
Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?
Haben Sie Übelkeit? Erbrechen?
Haben Sie Völlegefühl? Blähungen?

Haben Sie Sodbrennen? Saures Aufstoßen?
Wann hatten Sie das letzte Mal Ihre Monatsblutung?
Gehen Sie regelmäßig zur Frauenärztin / zum Frauenarzt?
Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrer Frauenärztin / Ihrem Frauenarzt?
Ist alles in Ordnung?
Haben Sie ungewöhnlichen Ausfluss oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr?
Benutzen Sie Verhütungsmittel wie Diaphragma?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe einen Verdacht auf Nieren**entzündung.**
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Urinuntersuchung und eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Sonographie:
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten
dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.
Urinprobe (Mittelstrahlurin):
Für die Urinuntersuchung geben Sie eine kleine Menge Urin/Wasser in einem sauberen Becher.Dafür waschen Sie zuerst die Genitalregion (= Geschlechtsbereich) mit einem Reinigungstuch. Lassen Sie
den ersten T eil des Urins in die T oilette laufen, dann den Mittelstrahl des Urins im Becher, und lassen Sie den Rest wieder in die T oilette. Dies hilft genauere T estergebnisse zu haben.
Haben Sie noch Fragen an mich?

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen.
Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.
Es geht um Frau Gaby Wegner. Sie ist 59 Jahre alt, am 01.02.1963 geboren, 157 cm groß und wiegt 65 kg.
Sie stellt sich mit seit gestern Abend bestehender, klopfender, progredienter, persistierender und linksseitiger Bauchschmerzen in der Flanke vor.
Laut Angaben der Patientin sind die Schmerzen beim Treppensteigen plötzlich aufgetreten.
Sie berichtet, dass die Schmerzen in den linken Unterbauch ausstrahlen und die Schmerzintensität bei 8/10 auf der Schmerzskala liegt.

Sie erwähnt, dass sie vor zwei Wochen ähnliche Beschwerden hatte und Cotrimoxazol für drei Tage eingenommen hat.
Begleitend klagt sie über Fieber (seit gestern 38,8 °C), Pollakisurie, Oligurie, Nykturie und Hämaturie seit zwei Tagen.
Außerdem berichtet sie über drei bis vier Episoden Diarrhoe seit gestern, schmerzbedingte Insomnie und Appetitlosigkeit.

Vegetativanamnestisch ergaben sich Diarrhoe (3–4×), schmerzbedingte Insomnie, Inappetenz sowie Menopause vor 15 Jahren.

Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie einen Harnwegsinfekt vor 2–3 Wochen, arterielle Hypertonie seit 5 Jahren sowie eine Glomerulonephritis vor 40 Jahren.
Sie nannte folgende Operationen: Tonsillektomie im 10. Lebensjahr, Appendektomie im 18. Lebensjahr und Sectio caesarea vor 25 Jahren.

Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Nebivolol 10 mg (1-0-0) und Candesartan 4 mg (1-0-0).
In der Allergieanamnese erwähnte sie eine Allergie gegen Nickel und braunes Pflaster, die sich in Pruritus und Erythem äußert.

Bei der Noxenanamnese berichtet sie lediglich über gelegentlichen Konsum von Sekt oder Wein. Drogen werden verneint.

Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt und arterielle Hypertonie beim Vater. Ihre Mutter litt an Glomerulonephritis, war dialysepflichtig und erhielt eine Nierentransplantation. Sie verstarb nach einer Herzoperation. Ihr Großvater hatte Ikterus.

Sozialanamnestisch ist sie Angestellte beim Einwohnermeldeamt, verheiratet und wohnt mit ihrem Mann zusammen.
Sie hat eine Tochter und treibt keinen Sport.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Pyelonephritis hin. Klopfende, persistierende Flankenschmerzen, Fieber, Pollakisurie, Dysurie, Nykturie, Oligurie und Hämaturie sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen ein akuter Schub einer chronischen Glomerulonephritis, eine Urolithiasis, eine Divertikulitis und eine Adnexitis in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.
Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Urinstatus, Urinkultur sowie eine Stuhldiagnostik (FOBT – Fecal Occult Blood Test) kontrollieren lassen.
Anschließend werde ich eine Sonographie der Nieren durchführen und ein Konsil in der Urologie oder Nephrologie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, sollte die Patientin stationär aufgenommen werden (aufgrund der Nierenvorgeschichte).
Als kausale Therapie schlage ich eine Antibiotikatherapie vor (Fluorchinolon, z. B. Ciprofloxacin für 10 Tage p.o.; alternativ Cephalosporin, z. B. Ceftibuten).
Als weitere Therapie empfehle ich Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution sowie die Gabe eines Analgetikums (z. B. Metamizol), eines Antiemetikums, eines Antipyretikums und eines Spasmolytikums (z. B. Tolperison, Methocarbamol, Tizanidin oder Baclofen).

Reaktionen:

Darf ich nach der Einnahme von Medikamenten nach Hause? Soll ich hierbleiben? Pyelonephritis - Diskusprolaps

- Ja, Das kann ich im Moment noch nicht wissen, wir warten auf die Befunde der Untersuchung und können dann entscheiden.
- Kann jemand anderes Ihre Sachen mitbringen?
- Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.

- Ich weiß, niemand bleibt gerne im Krankenhaus
- Es ist nicht gefährlich, keine Sorge, aber es wäre besser, wenn Sie hier bei uns bleiben, damit wir schnell reagieren können, wenn sich bei Ihnen etwas Neues entwickelt.

Ich habe Übelkeit und Schmerzen, könnten Sie mir helfen? Pyelonephritis - Cholelithiasis

- Ja, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Ich verstehe, dass Sie starke Schmerzen haben, aber ich brauche einige weitere Informationen. Könnten Sie die Schmerzen noch ein bisschen aushalten, bis unser Gespräch zu Ende ist? Prima! Auf jeden Fall wäre das besser für die Diagnose. Ich versuche möglichst schnell zu beenden.

- Frau Breiterweg, ich merke, dass Sie starke Schmerzen haben, aber bevor die Untersuchungen kann ich Ihnen leider kein Schmerzmittel geben. Das ist wichtig für die richtige Diagnose. Aber ich versuche das Gespräch ganz schnell zu beenden. Bitte halten Sie die Schmerzen für kurze Zeit aus.

Die Patientin hat vor 2 Wo. ohne Rezept Antibiotikum eingenommen. Pyelonephritis

- Ich verstehe, dass die Medikamente Ihnen bereits geholfen haben. Aber bitte nehmen Sie keine Medikamente ohne ärztlichen Rat ein. Das kann sehr gefährlich sein und Nebenwirkungen verursachen.

Intravenöse Pyelographie (IVP)

- Eine intravenöse Pyelographie (IVP) ist eine Untersuchung, die verwendet wird, um die Nieren, Harnleiter und Blase mittels Röntgenaufnahmen sichtbar zu machen. Bei einer IVP wird ein Kontrastmittel in eine Vene in Ihrem Arm injiziert und dann werden Röntgenaufnahmen gemacht, während das Kontrastmittel durch Ihre Nieren und Harnwege fließt. Auf diese Weise

können Veränderungen oder Blockaden in den Harnwegen festgestellt werden.

AKUT PYELONEPHRITIS

(1)

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Gaby Wegner / Else Breiterweg
- 59 J.
- *01.02.1963
- 1,57 m/ 1,67 m
- 65 kg / 76,6 kg

-Hauptbeschwerde (Asthenie und Cephalgie)

- Ich habe Übelkeit und Schmerzen, können Sie mir helfen?
  - Ja, auf jeden Fall, aber ich brauche mehr Informationen darüber. Können Sie mir zeigen wo genau sind die Schmerzen. Ausstrahlung? Seit wann? Wie genau? Wie stark? Immer da? Wie haben sich begonnen? Ähnliche Beschwerden früher?
- Ich habe auch Globusgefühl, Übelkeit, Schwindel seit 2 Wochen, nach der Einnahme von Cotrimoxazol einmal 3 Tabletten zusammen zu Hause selbst wegen HWI (vor 3 Wochen). Das hat mir geholfen.
  - Das ist wirklich nicht gut, Antibiotika ohne Rezept einzunehmen. Die Symptome, die Sie jetzt erleben, sind tatsächlich Nebenwirkungen des Antibiotikums.
  - Ich empfehle, in Zukunft Medikament nur nach Rücksprache mit einem Arzt einzunehmen, um solche Probleme zu vermeiden.

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Ja natürlich, ich verstehe, dass Sie starke Schmerzen haben, aber ich brauche einige weitere Informationen. Könnten Sie die Schmerzen noch ein bisschen aushalten, bis unser Gespräch zu Ende ist? Primär auf jeden Fall wäre das Besser für die Diagnose. Ich versuche möglichst schnell zu beenden.

- Flanken- (Rücken-)schmerzen
  - Linksseitig
  - Seit gestern Abend bzw. Mittag / seit 3 Tagen
  - Persistierend
  - Progredient
  - Klopfend
  - Ausstrahlung in den linken Unterbauch
  - Plötzlich beim Treppensteigen
  - NRS: 8/10
  - ähnliche Beschwerden vor 2 Wo.

Ich verstehe, dass die Medikamente Ihnen bereits geholfen haben. Aber bitte nehmen Sie ~~ohne~~ keine Medikamente ohne ärztlichen Rat ein. Das kann gefährlich sein und Nebenwirkungen verursachen.

- Begleitend: Ich habe häufig das Bedürfnis seit 2 Wochen, auf die Toilette zu gehen, sogar nachts, obwohl jedes Mal nur ein paar Tropfen herauskommen. Und das ist manchmal schmerzhaft
  - Pollakisurie: Haben Sie bemerkt, ob Sie kleine oder große Mengen Wasser lassen?
  - Dysurie: Tut es Ihnen weh oder haben Sie brennende Gefühl beim Wasserlassen?
  - Nykturie: Müssen Sie nachts häufig aufstehen, um Wasser zu lassen? Wie oft müssen Sie am Tag / nachts auf die Toilette? Öfter als gewöhnlich?
  - Hämaturie seit 2 Tagen auch vor 2 Wo. Haben Sie eine Harnfarbveränderung bemerkt? Ist der Harn trüb, klar oder blutig?

-vegetative Symptomatik

- Fieber: seit gestern, 38,8 (oral/axillär gemessen) Wo haben Sie sie gemessen?
- ~~Schüttelfrost~~
- ~~Emesis~~
- ~~Polyurie~~
- Diarrhoe seit gestern, 3-4 Mal Wie sah den Stuhl aus? V
- Inappetenz
- Schmerzbedingte Insomnie

-gyn

- Menopause vor 15 J. (Menarche mit 11. LJ) Besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauarzt? Alles war in Ordnung?

-Vorerkrankungen

- HWI vor 2/3 Wochen

(„Halten Sie das Gespräch trotzt der Schmerzen bis zum ende Görüşme sonuna kadar aus?)

- aHT seit 5 Jahren
  - Seit wann? Wann war die letzte Messung und wie hoch war sie?
- GN vor 40 J. / mit 15 LJ (manchmal Schub, regelmäßige Kontrolle bei Urologen) Vor oder Seit 40 J.?
- Impfung: vollständig

-Vor-OPs

- TE mit 10. LJ
- AE mit 18. LJ
- Sectio caesarea vor 25 J.

-Medikation

- Nebivolol 10 mg Tbl. 1-0-0 (*B1-Selektiv Betablocker*)
- Candesartan 4 mg Tbl. 1-0-0 / Valsacor (Valsartan 80 mg Tbl.) (*AT1-Rezeptorantagonisten*)
- Omeprazol (*PPI*)

-Allergien

- Nickelallergie □ *Achtung bei Osteosynthese mit Nickelmaterial (Schrauben, Nägel)*
- Braunes Pflaster - äußert sich mit Pruritus und Erythem: Juckreiz und Rothaut

-Noxen

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin Haben Sie schon geraucht?
- Alkoholkonsum: gel. Sekt und Wein (*Sekt ist ein Schaumwein*) /
- Drogenkonsum wurde verneint
  - *Bestimmte Drogen in Kombination mit bestimmten Medikamenten können zu schweren Nebenwirkungen führen* Das ist wichtig. Weil Drogen Wechselwirkungen mit Medikamenten haben können und ich wüde Ihnen vielleicht Medikamente verordnen.

-Sozialanamnese

- Einwohnermeldeamt (Stress und Spaß)
- Verheiratet, wohnt mit Mann zusammen: mein Mann arbeitet auch dort
- 1 Tochter
- Kein Sport
  - Das wäre besser für Ihre Gesundheit, wenn Sie regelmäßig Sport treiben. Sie können täglich mindestens 30 Minuten spazieren gehen oder sich in einem Sportverein anmelden.
- Keine Reise im Ausland

-Familienanamnese

- Vater (? J.): gesund / MI vor 2J und aHT
- Mutter (? J.): t Jung nach einer Herz-OP/Bypass-OP/Bruck, GN (Dialyse und Nierentransplantation) Nierenersatzverfahren / Nierenverpflanzung
- Opa (? J.): t An Ikterus er hatte Gelbsucht

- Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit! Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Ich habe einen Verdacht auf **Nierenentzündung**. Aber das bleibt nur eine Vermutung und wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich ein wenig Blut abnehmen. Danach werden wir eine Bauchultraschall und eine Urinuntersuchung machen. Wissen Sie, was das ist?

Sonographie:

Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.

Urinprobe (Mittelstrahlurin):

Für die Urinuntersuchung geben Sie eine kleine Menge Urin/Wasser in einem sauberen Becher.

Sie hatte diese Beschwerden seit der Kinderheit?

Dafür waschen Sie zuerst die Genitalregion (= Geschlechtsbereich) mit einem Reinigungstuch. Lassen Sie den ersten Teil des Urins in die Toilette laufen, dann den Mittelstrahl des Urins im Becher, und lassen Sie den Rest wieder in die Toilette. Dies hilft genauere Testergebnisse zu haben.

Haben Sie noch Fragen?

3

-Fragen

- Darf ich nach der Einnahme von Medikamenten nach Hause? Soll ich hierbleiben?
  - Aufgrund Ihrer Nierenvorgeschichte ist es sicherer, dass Sie hier bleiben.

Das kann ich im Moment noch nicht wissen, wie weiter oft die Befunde der Untersuchung und zom Arzt-Arzt-Gespräch entscheiden

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Gaby Wegner, 59** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit 3 Tagen / gestern Abend linkseitige Flankenschmerzen, die in den linken Unterbauch ausstrahlen. Die Schmerzen haben plötzlich beim Treppensteigen begonnen und sind seitdem persistierend und progredient. 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Sie beschreibt ähnliche Beschwerden vor 2 Wochen, aber sie hat selbst Cotrimoxazol 3 Tabletten zusammen eingenommen. Sie hat seit 2 Wochen auch Globusgefühl, Vertigo, Nausea und Diarrhoe, die für mich Nebenwirkungen der Einnahme von Cotrimoxazol sind.

Begleitend sind seit 3 Tagen Pollakisurie, Dysurie, Nykturie, seit 2 Tagen Hämaturie, Inappetenz und schmerzbedingte Insomnie. Sie hat seit gestern Fieber, 38,8° orale gemessen. **Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.**

Sie leidet seit 5 Jahren an arterielle Hypertonie und nimmt regelmäßig Nebivolol und Valsartan dagegen ein. Auch vor 40 Jahren an Glomerulonephritis und besucht regelmäßig ihr Urologe.
Sie hatte vor 40 Jahren eine Glomerulonephritis.
In der Familienanamnese gibt es GN (Dialyse und Nierentransplantation).

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf akute Pyelonephritis. An Differentialdiagnosen sind zu nennen Akuter Schub einer chronischen GN, Nephrolithiasis, Divertikulitis, Adnexitis.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen, dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, Entzündungsparameter, Leber-Nierenwerte, E-lyte, Urinstatus, Urinkultur und FOBT.

Anschließend ist eine Nieren-Sonographie durchzuführen und ein Urologisches Konsil anzufordern.

Ich werde sie stationär aufnehmen (aufgrund die Nierengeschichte).

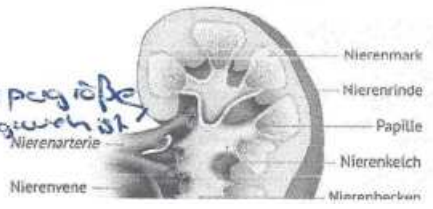
Als <u>initiale Therapie</u> empfehle ich Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytensubstitution, Analgetikum (Metamizol), Antipyretikum und Spasmolytikum.
<u>Als kausale Therapie</u>, schlage ich Antibiotikatherapie vor (Fluorchinolon z.B. Ciprofloxacin für 10 Tage p.o (Alternativ: Cephalosporin z.B. Ceftibuten)

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

Der BMI wird berechnet, indem man das Gewicht im Kilogram durch die Körpergröße im Metern zum Quadrat teilt

-Fragen

Niere im Anschnitt



Was ist BMI? Rechnen Sie bitte. Die Patientin wirkt auf ersten Blick, normalen BMI zu haben.

Er zeigt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße, dient zur Beurteilung, ob jemand untergewichtig oder übergewichtig ist

Was ist der Normbereich von BMI? 18,5-25

Welches akute Symptom hat Sie? Warum Vertigo als NW von AB? Wegen Ototoxizität, Schädigung des Innenohrs / des Gleichgewichtsorgans (besonders Aminoglykosid-Antibiotikum ☐ Streptomycin, Gentamycin)

(besser gegen HWI: Trimethoprim / Fosfomycine)

Was ist Cotrimoxazol? Eine Kombination aus Trimethoprim und Sulfamethoxazol

Welche Art von Hämaturie hat sie? Makrohämaturie

Was ist Mikrohämaturie? Nur durch Labor nachweisbar, bei Urinuntersuchung (Urinstatus / Urinsediment)

Warum hat Pat. Diarrhö? Nebenwirkung von AB

Was ist Valsacor / Candesartan? Valsartan 80 mg, AT1-Rezeptorantagonisten (Antihypertensivum)

Nebivolol? Kardioselektiven Beta-Blocker

Omeprazol? Protenpumpeninhibitor (PPI) gegen GERD

Warum hatte ihr Opa Ikterus? Es kann sein wegen einer **Leberzirrhose**, **Cholezystitis**, oder **hämolytische Anämie** (Malaria, Herzklappenersatz mit mechanischer Prothese)

Was ist sie von Beruf? Was ist das Einwohnermeldeamt? Für wen arbeitet sie? Das Einwohnermeldeamt ist eine Behörde, bei der Bürger ihre neue Wohnadresse melden müssen. Sie arbeitet für die Stadt. / Sie arbeitet für die Dienststelle, bei der wir unsere neue Adresse registrieren können

Was ist der Goldstandard dieser Diagnose (Akuter Schub einer chronischen GN)? Biopsie (*Gewebeprobe*)

Welchen Test kann man in der Notaufnahme machen? Urinstix-Test (Urinteststreifen)

Was erwarten Sie bei Urinstix-Test: Nitrit erhöht, Leukozyturie (ggf. Erythozyturie und tubuläre Proteinurie)

Verschreiben Sie AB? Worauf achten Sie? Antibiogramm, Retentionsparameter

Welche AB verschreiben Sie? Flurochinolone (Ciprofloxacin oder Levofloxacin), Cephalosporin 2. Oder 3. Generation (Cefuroxime, Cefexim), Aminopenicillin

Welches Antibiotikum ist wichtiger bei Pyelonephritis? **Ciprofloxacin**

Warum vermeiden die Ärzte derzeit Cipro zu verschreiben? Keimresistenz, schwere und langanhaltende NW im Bereich Muskeln, Gelenke und Nervensystem

NW von Ciprofloxacin? = Breitspektrumantibiotikum aus der Gruppe der Fluorchinolone

- Nausea, Diarrhoe
- **Photosensibilisierung** (Sonnen- UV-Licht vermeiden) ☐ Exanthem
- HRST (QT-Zeit Verlängerung, Torsades-de-Pointes-Arrythmien = ventrikulären Tachykardie)
- Stenose/Insuffizienzen der Herzklappen
- Tendinitiden/Sehnenschäden (**Achilessehnenentzündung**), Myalgien, Arthralgien
- Peripheren/zentralen Nervensystems Wirkungen (Gangstörung, Neuropathien)

Welches Risiko besteht bei dieser Patientin? Urosepsis

Wer ist Achilles? zeigen Sie wo Achillessehnen liegt? Achilles ist eine Figur aus der griechischen Mythologie und der Held in Homers Epos, der Ilias. Er war außerhalb seiner Ferse unbesiegbar, weil seine Mutter ihn an der Ferse in ein magisches Wasser tauchte. Diese Schwäche führte später zu seinem Tod, als er von einem Pfeil an der Ferse getroffen wurde.

Sie sind krank und die Arztpraxen sind zu? Sie sind nicht lebensbedrohlich erkrankt, können jedoch nicht bis zur nächsten Sprechzeit warten? Dann helfen Haus- und Fachärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst, medizinische Hilfe rund um die Uhr

Beispiele für Eisenmangelanämie:

- Mangelhafte Ernährung: **Vegetarismus**
- **Verminderte Eisenresorption**: Morbus Crohn, nach Gastrektomie
- Bei Frauen: **Menorrhagie, Schwangerschaft** (und **Stillzeit**)
- **Gastrointestinale Blutungen** (Ulzera, Hämorrhoiden, Karzinom)
- Operationen usw.

Beispiele für B12-Mangel-Anämie:

- Mangelhafte Ernährung
- Mangel bei fehlendem Intrinsic Factor (IF)
    - **Perniziöse Anämie** = Autoimmunerkrankung mit chronischer Gastritis
    - **Magenresektion**
    - Zöliakie (= Glutenintolerenz, umg. *Heubner-Syndrom / einheimische Sprue*)
- Medikamente wie Metformin oder PPI
- **Alkoholmissbrauch**

Pyelonephritis

= eine Nierenbeckenentzündung mit Beteiligung des Nierenparenchyms (meist durch bakterielle Infektion verursacht)

Ätiologie: kann **über die ableitenden Harnwege** (aszendierend) oder **auf dem Blutweg** (hämatogen-deszendierend) entstehen ❑ Häufigsten Erreger: E.Coli, Kokken, Klebsiellen, Proteus

- Weibliches Geschlecht (kurze Harnröhre) sowie Schwangerschaft
- Urolithiasis
- Benigne Prostatahyperplasie
- Diabetes
- Fehlbildungen
- Analgetika-Abusus
- Morbus Crohn

Risikofaktoren: Vesikoureteraler Reflux, Neurogene Harnblasen, aHT

Symptome:

- Akute: Fieber, Schüttelfrost, Dysurie, Flankenschmerzen (ggf. gürtelförmige Schmerzen / Rückenschmerzen)
- Chronische: Müdigkeit und Abgeschlagenheit, subfebrile Temperaturen, Nausea und Brechreiz (= das Gefühl, Erbrechen zu müssen), Gewichtsabnahme, Pollakisurie

Diagnostik:

- KU: Klopfschmerzen in der Lendengegend
- Labor: BSG, CRP und Leukozyten erhöht
- Urinstatus: Nitrit erhöht, Leukozyturie (ggf. Erythozyturie und tubuläre Proteinurie)
- Urinkultur mit Erreger- und Resistenztestung
- Nieren-Sonographie (ggf. CT)

Therapie:

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr (min 1,5 L/Tag)
- Antibiotika: Fluorchinolon z.B. **Ciprofloxacin** für 10 Tage p.o (Alternativ: Cephalosporin z.B. **Ceftibuten**)
- Ggf. Analgetikum, Spasmolytikum
- ⇨ Nach der Therapie: Überprüfung der Laborwerte

Komplikationen: Urosepsis, Paranephritischer Abszess, Hypertonie

Glomerulonephritis

- Primäre Glomerulonephritis
  - Minimal change Glomerulonephritis (Lipoidnephrose)
  - Membranöse Glomerulonephritis
  - Fokal segmentale Glomerulosklerose (FSGS)
  - Membranoproliferative Glomerulonephritis
  - Rasch progrediente Glomerulonephritis (Crescentic Glomerulonephritis)
  - Mesangioproliferative Glomerulonephritis (= **IgA-Nephritis / Morbus Berger**)
  - Postinfektiöse Glomerulonephritis
- Sekundäre Glomerulonephritis (im Rahmen systemischer Grunderkrankungen)
  - Diabetes mellitus
  - Lupus erythematodes
  - Amyloidose
  - Goodpasture-Syndrom
  - Granulomatose mit Polyangitis
  - Purpura Schönlein-Henoch
  - Mikroskopische Polyangiitis
- Erbliche Formen
  - Alport-Syndrom □ zusätzlicher Affektion von Innenohr und Auge
    - 80% Männern (weil X-chromosomal-dominant)

Symptome: Müdigkeit und Krankheitsgefühl
Hypotonie
Ödeme (v.a. an Augenlidern und Beinen)
Verminderte Urinmenge (Oligurie
Hematurie, Proteinurie

16. Hypothyreose s.133

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Viele umgangssprachliche Wörter, spricht sehr leise

- Warum habe ich so lange gewartet?